Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг
2025 йил “____”_____даги
“_____”-сонли буйруғига
___-ИЛОВА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН КАРДИОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ

“ИНФЕКЦИОН ЭНДОКАРДИТ” НОЗОЛОГИЯСИ БУЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАР

ТОШКЕНТ – 2025

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси соғлиқни
сақлаш вазири
А.А. Худаяров
_____
«____»_____2025 й .

“ИНФЕКЦИОН ЭНДОКАРДИТ” НОЗОЛОГИЯСИ БУЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАР

ТОШКЕНТ – 2025

«КЕЛИШИЛГАН»
РИКИАТМ директори
Х.Ғ. Фозилов
"____" _____ 2025 йил

“ИНФЕКЦИОН ЭНДОКАРДИТ” НОЗОЛОГИЯСИ БУЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАР

ТОШКЕНТ 2025

ИНФЕКЦИОН ЭНДОКАРДИТ

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	**Нозологик номланиши:**	**Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**		**Нозология бўйича стационар шароитда ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
И33	Ўткир ва сурункали эндокардит:	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
И33.0	Ўткир ва сурункали инфекцион эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
И33.9	Ўткир эндокардит аниқланмаган	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
И38	Эндокардит, клапан аниқланмади	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист,	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог,

			клиник фармаколог, ЛОР		пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
И39	Эндокардит ва клапанларнинг шикастланиши бошқа рубрикаларда таснифланган касалликларда:	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
И39.2	Уч бурчак клапанининг шикастланиши бошқа рубрикаларда таснифланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
И39.1	Аорта клапанининг шикастланиши бошқа рубрикаларда таснифланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
И39.0	Митрал клапанининг шикастланиши бошқа рубрикаларда таснифланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог

И39.3	Пульмонар артерия клапанининг шикастланиши бошқа рубрикаларда таснифланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
И39.4	Кўплаб клапанларнинг шикастланиши бошқа рубрикаларда таснифланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
И39.8	Эндокардит, клапан аниқланмаган, бошқа рубрикаларда таснифланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
Т85.7	Бошқа ички протез қурилмалар, имплантлар ва трансплантатларга боғлиқ инфекция ва яллиғланиш реакциялари.	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенцион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пульмонолог, ЛОР, офтальмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог

ХКТ-11 бўйича кодланиши:	**Нозологик номланиши:**	**Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**		**Нозология бўйича статсионар шароитда ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
BA80	Ўткир эндокардит:	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
BA80.0	Ўткир инфекцион эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
BA80.1	Ўткир эндокардит бошқа бўлимларда таснифланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
BA80.9	Ўткир эндокардит аниқланмаган	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог,

					невропатолог, нефролог клиник фармаколог
BA81	Сиринкали эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
BA81.0	Сиринкали инфекцион эндокардит	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
BA81.1	Сиринкали эндокардит бошқа бўлимларда тасниfланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
BA81.9	Сиринкали эндокардит аниқланмаган	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник фармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник фармаколог
BA82	Эндокардит, юрак клапанлари касаллиги аниқланмаган	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист,	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Фтизиатр, эндокринолог,

			клиник fармаколог, ЛОР		пилмонолог, ЛОР, oftалмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирurг, микробиолог, невропатолог, hefролог клиник fармаколог
BA82.0	Эндокардит, юрак клапанлари касаллиги аниқланмаган	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник fармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирurг /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Ftизиатр, эндокринолог, пилмонолог, ЛОР, oftалмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирurг, микробиолог, невропатолог, hefролог клиник fармаколог
BA83	Эндокардит ва юрак клапанлари зарарланиши бошқа бўлимларда тасниfланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник fармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирurг /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Ftизиатр, эндокринолог, пилмонолог, ЛОР, oftалмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирurг, микробиолог, невропатолог, hefролог клиник fармаколог
BA83.0	Эндокардит бошқа бўлимларда тасниfланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник fармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирurг /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Ftизиатр, эндокринолог, пилмонолог, ЛОР, oftалмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирurг, микробиолог, невропатолог, hefролог клиник fармаколог
BA83.1	Митрал клапан зарарланиши бошқа бўлимларда тасниfланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник fармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирurг /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Ftизиатр, эндокринолог, пилмонолог, ЛОР, oftалмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирurг, микробиолог, невропатолог, hefролог клиник fармаколог

BA83.2	Аорта клапани зарарланиши бошқа бўлимларда тасниғланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник fармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Ftизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник fармаколог
BA83.3	Трикуспидал клапан зарарланиши бошқа бўлимларда тасниғланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник fармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Ftизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник fармаколог
BA83.4	Ўпка артериясининг клапани зарарланиши бошқа бўлимларда тасниғланган касалликларда	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник fармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Ftизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник fармаколог
AB75.6	Кандидоз эндокардити	ВОП/Терапевт/Кардиолог	Ревматолог, Инфекционист, клиник fармаколог, ЛОР	Кардиолог/ кардиохирург /реаниматолог/	Ревматолог, Инфекционист, Интервенсион аритмолог Ftизиатр, эндокринолог, пулмонолог, ЛОР, офталмолог, гематолог, токсиколог, нейрохирург, микробиолог, невропатолог, нефролог клиник fармаколог

***стандартни тўлдириш жараёнида нозология, унинг катталар, хомиладорлар, болалар ва қарияларда кечуви ҳамда нозология бўйича касалликни даври хусусиятидан келиб чиқиш талаб этилади.**

Шунингдек, нозология га тўғри келмайдиган жадвалларни тўлдириш тавсия қилинмайди. (Мисол учун, жаррохлик амалиёти нозологиясида ўтказилмаса (ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ) жадвали тўлдирилмайди ёки нозологияда паллиатив даво кўзда тутилмаса – (ПАЛЛИАТИВ ДАВО) жадвали тўлдирилмайди.

ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ва ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи Амбулатор ёрдам
		Амбулатор ёрдам		Стационарная помощь				
		ОШП/ОП	МПЦП	Районная (городская) больница	ОШП/ОП	ЛПУ на уровне республики		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Семейный врач	+					Ўткир асоратланмаган эндокардитдан кейин ойига бир марта 3 ой давомида	Амбулатор кузатув ўткир эндокардитда 3 ой, сурункали эндокардитда СЮЕ билан бўлса - умрбод; Стационар даволаниш: 10-12 кун*
	2. Кардиолог		+	+	+	+	- ўткир асоратланмаган эндокардитдан кейин 1 марта - 3 ой давомида ҳар ойда бир марта ўткир асоратланган эндокардитдан кейин - СЮЕ I-II ФС билан сурункали эндокардит учун: йилига 2 марта; - СЮЕ III-IV ФС билан сурункали эндокардит учун йилига 4 марта	
	3. Терапевт		+	+				
Изоҳ: * стационар шароитидаги даволаниш муддати бўлган госпитализация мақсадига боғлиқ. Стационар шароитидаги мутахассис кўриклари ҳар кунги бўлади.								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. ревматолог			+	+	+	Кўрсатмага биноан	
	2. инфекционист				+	+		
	3. Интервенцион аритмолог					+		

(қўшимча)	4. фтизиатр		+	+	+	+		
	5. эндокринолог		+	+	+	+		
	6. пульмонолог			+	+	+		
	7. лор		+	+	+	+		
	8. офтальмолог		+	+	+	+		
	9. гематолог			+	+	+		
	10. токсиколог			+	+	+		
	11. нейрохирург			+	+	+		
	12. микробиолог			+	+	+		
	13. невропатолог		+	+	+	+		
	14. нефролог		+	+	+	+		
	15. клиник фармаколог			+	+	+		
Изоҳ: Барча тор мутахассислар кўриги кўрсатмага биноан ташкиллаштирилади. Стационар шароитада тор мутахассисларнинг кўрик сони клиник ҳолатига мувофиқ ташкиллаштирилиши лозим.								
Асосий лаборатор текширувлар	1. Умумий қон таҳлили	+	+	+	+	+	- ўткир асоратланмаган эндокардитдан кейин 1 марта - 3 ой давомида ҳар ойда бир марта ўткир асоратланган эндокардитдан кейин - СЮЕ I-II ФС билан сурункали эндокардит учун: йилига 2 марта; - СЮЕ III-IV ФС билан сурункали эндокардит учун йилига 4 марта	
	2. Умумий сийдик таҳлили							
	3. АЛТ, АСТ, билирубин							
	4. Глюкоза	+	+	+	+	+		
	5. Креатинин	+	+	+	+	+		
	6. Мочевина	+	+	+	+	+		
	7. С-реактив оксил	+	+	+	+	+		
	8. Ревматоид фактор		+	+	+	+		

	9. Антистрептолизин-О		+	+	+	+		
	10. Қон гемокультурага экмаси			+	+	+		
Изоҳ: агар ОШП/ОП моддий-техник базаси ўткир фазали синамаларни (СРО, АСЛО, РФ) текшириш имкоянитига эга бўлса, оилавий шифокор томонидан бу текширувлар бажарилиши лозим. Стационар шароитида лаборатор текширувларнинг сони клиник ҳолатдан келиб чиққан тарзда аниқланади.								
Қўшимча лаборатор текширувлар	1. Коагулограмма, АЧТВ		+	+	+	+	Кўрсатмага биноан	
	2. Общий белок			+	+	+		
	3. Альбумин			+	+	+		
	4. Глобулины (α-, β-, γ-фракции)			+	+	+		
	5. Общий билирубин			+	+	+		
	6. Прокальцитонин			+	+	+		
	7. ВИЧ			+	+	+		
	8. гепатит Б ва С			+	+	+		
	9. Вассерман Реакцияси (PW)			+	+	+		
	10. Калий			+	+	+		
	11. Натрий			+	+	+		
	12. Тропонин			+	+	+		
	13. Д-димер				+	+		
	14. Мозговой натрийуретический пептид			+	+	+		
	1. . Гуруҳ ва қон резус омили ҳамда антиеритроцитар антителалар		+	+	+	+		
	2. Гемокультура таҳлили ПЦР усули билан			+	+	+		
	3. Юрак клапанларидан (протезларлардан) экмалари			+	+	+		
Изоҳ: Қон гуруҳи, гепатит В ва С, ОИВ га текширувлар жарроҳлик амалиётлар режалаштирилган беморлар учун бажарилиши лозим. Стационар шароитида лаборатор текширувларнинг сони клиник ҳолатдан келиб чиққан тарзда аниқланади.								
Асосий	1. ЭКГ	+	+	+	+	+	- ўткир	

инструментал текширувлар							**асоратланмаган эндокардитдан кейин 1 марта - 3 ой давомида ҳар ойда бир марта ўткир асоратланган эндокардитдан кейин - СЮЕ I-II ФС билан сурункали эндокардит учун: йилига 2 марта; - СЮЕ III-IV ФС билан сурункали эндокардит учун йилига 4 марта**	
	2. Трансторакал ЭхоКГ			**+**	**+**	**+**		
	3. Трансэзофагеал ЭхоКГ				**+**	**+**		
	4. Юракнинг МСКТ				**+**	**+**		
Изоҳ: Стационар шароитида ЭКГни сони клиник ҳолатдан келиб чиққан тарзда аниқланади.								
Қўшимча инструментал текширувлар	**1. ЭхоКГ**		**+**	**+**	**+**	**+**	**Кўрсатмага биноан**	
	2. Кўкрак қафаси рентгенографияси		**+**	**+**	**+**	**+**		
	3. Холтер бўйича ЭКГ ни мониторлаш				**+**	**+**		
	4. Инвазив коронарография				**+**	**+**		
	5. ЭФИ				**+**	**+**		
	6. Ички аъзолар УТТ		**+**	**+**	**+**	**+**		
	7. МРТ сердца с контрастированием				**+**	**+**		
	8. Патоморфологические исследования клапанов (протезов) сердца				**+**	**+**		

	9. Интралюминал (интраваскуляр) юрак ичи ЭхоКГ				+	+		
	10. Юрак катетеризацияси				+	+		
Изоҳ: Стационар шароитида инструментал текширувларнинг сони клиник ҳолатдан келиб чиққан тарзда аниқланади								

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	1. ЧА2ДС2-ВАСс ва ҲАС-БЛЕД шкалалари	+	+	+	+	+	Ҳар кўрикда	
Изоҳ: Эндокардит ва бўлмачалар фибрилляцияси бўлган беморлар ишемик инсульт хавфини баҳолаш учун ЧА2ДС2-ВАСс шкаласи қўлланилади. Эндокардит ва бўлмачалар фибрилляцияси бўлган беморлар орал антикоагулянтлар қўлланилганда қон кетиш эҳтимоллигини баҳолаш учун ҲАС-БЛЕД шкаласи қўлланилади.								

(МЕДИКАМЕНТОЗ ТЕРАПИЯ)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		РЕЖАЛИ тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохона-лари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Рўйхат асосида қарши-микробли дориларни қўллаш эҳтимоли 100% бўлган: А) Пенициллинлар: - Бензилпенициллин натрий тузи - Ампициллин Б) Цефалоспоринлар:	Бензилпенициллина натриевая соль 250 000-500 000 ЕД каждые 6 часов;; Суточную дозу делят на 4-6 введений.			+	+	+	суткалик доза 1.000.000-2.000.000 ЕД максимальная – 40.000.000-60.000.000 ЕД в сутки внутривенно	клиник ҳолатига боғлиқ

- Цефазолин В) б-лактамалар - Амоксициллин/клавуланат Г) Сульфонамидлар - Ко-тримоксазол	Ампициллин 2 г внутривенно каждые 4 часа.			+	+	+	Максимальная доза: 12 г/день	камида 4-8 ҳафта
	Цефазолин от 1 до 1,5 г в / в каждые 6 часов или 2 г в / в каждые 8 часов			+	+	+	Максимальная доза: 12 г/день	камида 4-6 ҳафта
	Амоксициллин / клавуланат В зависимости от степени тяжести инфекции, назначают 1000 мг/100 мг каждые 8 часов или 2000/200 мг			+	+	+		
	Ко-тримоксазол ➢ Сульфометоксазол 4 800 мг/день ➢ Триметоприм 960 мг/день (в/в в 4-6 введений)			+	+	+		
Инфекцион эндокардитни антибактериал даволаш, Стрептососсус спп. томонидан чақирилган. 1. Пенициллинга сезгир штаммлар (МИК<0,125 мг/л) оғиз бўшлиғи ва овқат ҳазм қилиш тизими стрептококклари	Бензилпенициллин - 12-18 млн. 4-6 введений ЕД, в/в;			+	+	+		Даволашнинг стандарт схемаси, 4 ҳафта давом этади. Протез клапанлари зарарланганда, даволаш муддати - 6 ҳафта.
	Амоксициллин-100-200 мг/кг/сут, в/в 4-6 введений;			+	+	+		
	Цефтриаксон 2 г/сут, в/в или в/м в 1 введение			+	+	+		
	[2]Бензилпенициллин - 12-18 млн. ЕД, в/в, 4-6 введений; или			+	+	+		Даволашнинг стандарт схемаси, 2 ҳафта

	[2]Амоксициллин- 100-200 мг/кг/сут, в/в, 4-6 введений; или			+	+	+		
	[2]Цефтриаксон + Гентамицин2 г/сут, в/в или в/м в 1 введение +3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение» или			+	+	+		
	[2]Нетилмицин 4-5 мг/кг/сут, в/в в 1 введение;			+	+	+		
Бета-лактамларга аллергияси бўлган беморларда	Ванкомицин - 30 мг/кг/сут, в/в в 2 введения;			+	+	+		4 ҳафта При поражении протезированных клапанов - длительность до 6 ҳафта.
1. Пенициллинга нисбатан чидамли штаммлар (МПК 0,250-2 мг/л)	[3]Бензилпенициллин- 500 000 ЕД каждые 6 часов; или			+	+	+	суткалик доза 2 000 000 ЕД; максимальная – 40 000 000-60 000 000 ЕД в сутки в/в	4 ҳафта (натив клапан) 6 ҳафта и > (протезирланган клапан)
	Амоксициллин- 100-200 мг/кг/сут, в/в в 4-6 введения.			+	+	+	Максимал доза: 12 г/кун	
	[4]Цефтриаксон 2 г/сут, в/в или в/м кажые 12-24 часа в течении 4-6 ҳафта. Плюс			+	+	+		
	[5]Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение.			+	+	+		

Бета-лактамларга аллергияси бўлган беморларда	**Ванкомицин - 30 мг/кг/сут, в/в, в 2 введения**			**+**	**+**	**+**		**4 ҳафта (нативный клапан) 6 ҳафта и > (протезированный клапан)**
1. Стафилококклар билан боғлиқ инфекцион эндокардитни антибактериал даволаш А) табиий клапанлар	**(Флу)клоксациллин или оксациллин 12 г/сут, в/в в 4-6 введений; или**			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати 4-6 ҳафта.**
	Ко-тримаксозол. Сульфаметоксазол 4800 мг/сут и Триметоприм 960 мг/сут (в/в, 4-6 введений) 1800 мг/сут в 3 введения. плюс			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати: 1 в/в +5 пер ос**
	Клиндамицин 1800 мг/день в 3 введения.			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати: 1 ҳафта.**
Пенициллинга ёки метициллинга сезгир стафилококларга аллергияси бўлган беморлар.	**Ванкомицин 30-60 мг/кг/сут, в/в в 2-3 введения или**			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати 4-6 ҳафта.**
	Даптомицин10 мг/кг/сут, в/в в 1 введение или			**+**	**+**	**+**		
	Ко-тримаксозол + Клиндамицин Сульфаметоксазол 4800 мг/сут и Триметоприм 960 мг/сут (в/в, 4-6 введений) 1800			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати 1 в/в+ 5 пер ос мг/сут в 3 введения.**
				+	**+**	**+**		
				+	**+**	**+**		

Б) протез қилинган клапанлар **Метициллинга сезгир стафилококк штаммлари**	**Оксациллин 12 г/сут в/в в 4-6 введений;** **+** **Рифампицин 900-1200 мг/сут, в/в или внутрь в 2-3 введения;** **+**			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати ≥6 ҳафта.**
	Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение;			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати 2 ҳафта**
Бета-лактамларга аллергияси бўлган беморлар, метициллинга сезгир стафилококк штаммлари.	**Ванкомицин 30-60 мг/кг/сут, в/в в 2-3 введения; +** **Рифампицин 900-1200 мг/сут, в/в в 2-3 введения;** **+**			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати ≥6 ҳафта**
	Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение;			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати 2 ҳафта**
2. Энтерококклар томонидан чақирилган инфекцион эндокардитни антибактериал даволаш **Бета-лактамларга ва гентамицинга сезгир штаммла**	**[6]Амоксициллин 200 мг/кг/сут, в/в в 4-6 введений;** **+**			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати 4-6 ҳафта**
	[6]Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение;			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати 2-6 ҳафта**
	[7]Ампициллин 200 мг/кг/сут, в/в в 4-6 введений; **+** **Цефтриаксон 4 г, в/в или в/м в 2 введения;**			**+**	**+**	**+**		**Даволаш муддати - 6 ҳафта**

	или							
	[8]Ванкомицин 30 мг/кг/сут, в/в в 2 введения + Гентамицин 3 мг/кг/сут, в/в или в/м в 1 введение;			**+**	**+**	**+**		
3. Глюкокортикостероиды[4]: - Преднизолон	**Преднизолон 30-40 мг в сутки**		**+**	**+**	**+**	**+**	**Преднизолон 30-40 мг в сутки**	**3-6 ой**
4. Блокаторлар РААС: А) иАПФ: - Эналаприл - Рамиприл - Периндоприл Б) БРА (сартанлар): - Валсартан - Лозартан - Кандесартан - Телмисартан - Азилсартан - Олмесартан	**иАПФ: - Эналаприл 2,5-20 мг 2 раз в день - Рамиприл 2,5-10 мг 1 раз в день - Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 раз в день - Периндопил аргинин 2,5-10 мг 1 раз в день БРА: - Валсартан – 40-320 мг 2 раз в день - Лозартан 25-100 мг 1 раз в деь - Кандесартан 4-32 мг 1 раз в день - Телмисартан 10-80 мг 1 раз в день - Азилсартан 20-80 мг 1 раз в день - Олмесартан 10-40 мг 1 раз в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**иАПФ: - Эналаприл 2,5-20 мг - Рамиприл 2,5-10 мг - Периндоприл эрбумин 2-8 мг - Периндопил аргинин 2,5-10 мг БРА: - Валсартан – 40-320 мг - Лозартан 25-100 мг - Кандесартан 4-32 мг - Телмисартан 10-80 мг - Азилсартан 20-80 мг - Олмесартан 10-40 мг**	**Даволаш муддати клиник ҳолатига боғлиқ**
5. АРНИ[5]: - Сакубитрил/Валсартан	**24/26 мг (50 мг), 49/51 мг (100 мг) или 97/103**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**100-400 мг**	**Даволаш муддати клиник**

	мг (200 мг). По 1 таблетке 2 раза в день (доза подбирается под контролем АД)							ҳолатига боғлиқ
6. Бета-блокаторлар: - Бисопролол - Метопролол - Небивалол - Карведилол	- Бисопролол 2,5-10 мг 1 раз в день - Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 раз в день - Небивалол 2,5-10 мг 1 раз в день - Карведилол 3,125-25 мг кунлик дозаси 2-3 раза в день	+	+	+	+	+	- Бисопролол 2,5-10 мг - Метопролол сукцинат 25-100 мг - Небивалол 2,5-10 мг - Карведилол 3,125-25 мг	Даволаш муддати клиник ҳолатига боғлиқ
7. Антагонистлар минералокортикоидных рецепторларни: - Спиронолактон - Эплеренон	- Спиронолактон 25-50 мг по 1 табл. (капс) 1 раз в день; - Эплеренон 25-50 мг по 1 табл. 1 раз в день.	+	+	+	+	+	- Спиронолактон 25-50 мг - Эплеренон 25-50 мг	Даволаш муддати клиник ҳолатига боғлиқ
8. СГЛТ2-ингибиторы: - Эмпаглифлозин - Дапаглифлозин	- Эмпаглифлозин 10-25 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Дапаглифлозин 10 мг по 1 табл. 1 раз в день.	+	+	+	+	+	- Эмпаглифлозин 10-25 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Дапаглифлозин 10 мг по 1 табл. 1 раз в день.	Даволаш муддати клиник ҳолатига боғлиқ

Изоҳ:

Асосий гуруҳдаги қарши-микробли препаратлар эмпирик тарзда ёки аниқланган қўзғатувчига қараб якка тартибда ёки комбинация шаклида қўлланилади.

Қўшимча дори воситалари ҳам мавжуд бўлиб, улар асосий рўйхатдаги препаратлар билан бирга қўлланади (қўллаш эҳтимоли 100% дан камроқ).

1. 65 ёшдан ошган беморларда, буйрак касалликлари ва бош мия асабларининг ВИИИ жуфтлиги шикастланганида афзал кўрилади.

2. Асоратланмаган эндокардит ва нормал буйрак функциясига эга беморларга тавсия этилади.

3. 65 ёшдан ошган беморларда ва буйрак фаолияти бузилиши ёки ВИИИ (вестибуло-кохлеар) асаби фаолияти бузилишларида афзал ҳисобланади.

4. Даволаниш давомида периферик қон манзарасини, жигар ва буйрак ҳолатини назорат қилиш керак.

5. Гентамицин дозаси қон зардобидаги максимал концентрацияга эришиш учун танланади.

6. Симптомлар 3 ойдан ортиқ сақланиб қолганда ёки протез қилинган клапанлар шикастланганда даволаниш 6 ҳафтагача давом эттирилади.
7. Е. фаесалис га нисбатан фаоллик.
8. Е. фаесалис га нисбатан фаол эмас.
Стационар даражасида олинган тавсияларга асосланиб, амбулатор даражадаги даволашни узвийлигини таъминлаш мақсадида бошқа антибиотиклар ҳам қўлланилиши мумкин, улар юқорида кўрсатилмаган.
Бета-блокаторлар, РААТ блокаторлари (ААФи ёки сартанлар), МКРА ва СГЛТ2-ингибиторлари эндокардитнинг носпецифик терапияси деб ҳисобланади ва барча беморларга буюрилиши мумкин

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		РЕЖАЛИ тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
1. Орал антикоагулянтлар[1]: - Ривароксабан - Апиксабан	- Ривароксабан 15-20 мг 1 маҳал - Апиксабан 2,5-5 мг 2 маҳал		+	+	+	+	- Ривароксабан 15-20 мг 1 маҳал - Апиксабан 2,5-5 мг 2 маҳал	Терапия муддати клиник ҳолатига боғлиқ
2. Бевосита антикоагулянтлар: - Гепарин - Эноксипарин	- Гепарин 5000 ТБ т/о 4 маҳал; - Эноксипарин 100 антиХа ТБ беморни 1 кг вазнига нисбатан 2 маҳал			+	+	+	- Гепарин 5000 ТБ т/о 4 маҳал; - Эноксипарин 100 антиХа ТБ беморни 1 кг вазнига нисбатан 2 маҳал	
3. Антиаритмиклар: - Амиодарон -Аллапинин - Пропафенон - Этацизин - Верапамил - Дилтиазем	- Амиодарон 200 мг тўйиндирш схемаси бўйича; - Аллапинин 25 мг 1 табл. маҳал; - Пропафенон 150 мг 1 табл. 3 маҳал; - Этацизин 50 мг 1		+	+	+	+	- Амиодарон 200 мг тўйиндирш схемаси бўйича; - Аллапинин 25 мг 1 табл. маҳал;	

	табл. 3 маҳал; - Верапамил 80-160 мг 1 табал. 2-3 маҳал; - Дилтиазем 90 мг 1 табл. 2 маҳал						**- Пропафенон 150 мг 1 табл. 3 маҳал; - Этацизин 50 мг 1 табл. 3 маҳал; - Верапамил 80-160 мг 1 табал. 2-3 маҳал; - Дилтиазем 90 мг 1 табл. 2 маҳал**	
4. Ивабрадин	**5-7,5 мг 1 табл. 2 маҳал**		**+**	**+**	**+**	**+**	**10-15 мг**	
5. Триметазидин	**80 мг 1 марта суткасига, 35 мг 2 марта суткасига**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**70-80 мг**	
6. Ранолазин	**500-1000 мг 2 марта суткасига**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**1000-2000 мг**	
7. Ҳалқа диуретиклар: - Фуросемид - Торасемид	**- Фуросемид 40 мг 1 табл. 1 маҳал; - Торасемид 10 мг 1 табл. 1 маҳал**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**- Фуросемид 40 мг 1 табл. 1 маҳал; - Торасемид 10 мг 1 табл. 1 маҳал**	
Изоҳ: [1]Эндокардит билан оғриган беморларда БФ борлигида орал антикоагулянтлари буюрилади.								

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		ШОШИЛИНЧ тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси КТМП	Бир курслик дозировка Туман (шаҳар) шифохоналари Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	ЛПУ на уровне области Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП		
Рўйхат асосида қарши-микробли дориларни қўллаш эҳтимоли 100% бўлган: А) Пенициллины: - Бензилпенициллина натриевая соль ампициллин Б) Цефалоспорины: - Цефазолин В) б-лактамы Амоксициллин / клавуланат Г) сульфаниламиды Ко-тримоксазол	Бензилпенициллина натриевая соль 250 000-500 000 ЕД каждые 6 часов;; Суточную дозу делят на 4-6 введений.			+	+	+	суткалик доза 1.000.000-2.000.000 ЕД максимальная – 40.000.000-60.000.000 ЕД в сутки внутривенно	камида 4-8 ҳафта
	Ампициллин 2 г внутривенно каждые 4 часа. Цефазолин от 1 до 1,5 г в / в каждые 6 часов или 2 г в / в каждые 8 часов			+	+	+	Максимальная доза: 12 г/день Максимальная доза: 12 г/день	камида 4-8 ҳафта
	Амоксициллин / клавуланат В зависимости от степени тяжести инфекции, назначают 1000 мг/100 мг каждые			+	+	+		

	8 часов или 2000/200 мг							
	Ко-тримоксазол ➢ **Сульфометоксазол 4 800 мг/день** ➢ **Триметоприм 960 мг/день (в/в в 4-6 введений)**			**+**	**+**	**+**		
1. Глюкокортикостероиды[2]: **- Преднизолон**	**Преднизолон 30-40 мг в сутки**		**+**	**+**	**+**	**+**	**Преднизолон 30-40 мг в сутки**	**3-6 месяцев**
2. Блокаторы РААС: **А) иАПФ:** **- Эналаприл** **- Рамиприл** **- Периндоприл** **Б) БРА (сартанлар):** **- Валсартан** **- Лозартан** **- Кандесартан** **- Телмисартан** **- Азилсартан** **- Олмесартан**	**иАПФ:** **- Эналаприл 2,5-20 мг 2 раз в день** **- Рамиприл 2,5-10 мг 1 раз в день** **- Периндоприл эрбумин 2-8 мг 1 раз в день** **- Периндопил аргинин 2,5-10 мг 1 раз в день** **БРА:** **- Валсартан – 40-320 мг 2 раз в день** **- Лозартан 25-100 мг 1 раз в деь** **- Кандесартан 4-32 мг 1 раз в день** **- Телмисартан 10-80 мг 1 раз в день** **- Азилсартан 20-80 мг 1 раз в день** **- Олмесартан 10-40 мг 1 раз в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**иАПФ:** **- Эналаприл 2,5-20 мг** **- Рамиприл 2,5-10 мг** **- Периндоприл эрбумин 2-8 мг** **- Периндопил аргинин 2,5-10 мг** **БРА:** **- Валсартан – 40-320 мг** **- Лозартан 25-100 мг** **- Кандесартан 4-32 мг** **- Телмисартан 10-80 мг** **- Азилсартан 20-80 мг** **- Олмесартан 10-40 мг**	**Длительность терапии клиник ҳолатига боғлиқ**
3. АРНИ[3]: **- Сакубитрил/Валсартан**	**24/26 мг (50 мг), 49/51 мг (100 мг) или 97/103 мг (200 мг). По 1 таблетке 2 раза в день**	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**	**100-400 мг**	**Длительность терапии клиник ҳолатига боғлиқ**

	(доза подбирается под контролем АД)							
4. Бета-блокаторы: - Бисопролол - Метопролол - Небивалол - Карведилол	- Бисопролол 2,5-10 мг 1 раз в день - Метопролол сукцинат 25-100 мг 1 раз в день - Небивалол 2,5-10 мг 1 раз в день - Карведилол 3,125-25 мг кунлик дозаси 2-3 раза в день	+	+	+	+	+	- Бисопролол 2,5-10 мг - Метопролол сукцинат 25-100 мг - Небивалол 2,5-10 мг - Карведилол 3,125-25 мг	Длительность терапии клиник ҳолатига боғлиқ
5. Антогонисты минералокортикоидных рецепторов: - Спиронолактон - Эплеренон	- Спиронолактон 25-50 мг по 1 табл. (капс) 1 раз в день; - Эплеренон 25-50 мг по 1 табл. 1 раз в день.	+	+	+	+	+	- Спиронолак-тон 25-50 мг - Эплеренон 25-50 мг	Длительность терапии клиник ҳолатига боғлиқ
6. СГЛТ2-ингибиторы: - Эмпаглифлозин - Дапаглифлозин	- Эмпаглифлозин 10-25 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Дапаглифлозин 10 мг по 1 табл. 1 раз в день.	+	+	+	+	+	- Эмпаглифлозин 10-25 мг по 1 табл. 1 раз в день; - Дапаглифлозин 10 мг по 1 табл. 1 раз в день.	Длительность терапии клиник ҳолатига боғлиқ

Изоҳ:

[2] Глюкокортикостероидлар учун кўрсатма: аутоиммун касалликлар билан боғлиқ эндокардит.

[3] АРНИ ЧҚ ОФ паст (<40%) бўлган эндокардитли беморларда РААТ блокаторларига қараганда афзалроқ.

Бета-блокаторлар, РААТ блокаторлари (ААФи ёки сартанлар), МКРА ва СГЛТ2-ингибиторлари эндокардитнинг носпецифик терапияси деб ҳисобланади ва барча беморларга буюрилиши мумкин.

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)	ШОШИЛИНЧ тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
	ОШП/ОП	КТМП	Туман	Вилоят	Республика		

Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши			(шаҳар) шифохоналари	даражасидаги тиббиёт муассасалари	даражасидаги тиббиёт муассасалари		
1. Орал антикоагулянтлар[1]: - Ривароксабан - Апиксабан	- Ривароксабан 15-20 мг 1 маҳал - Апиксабан 2,5-5 мг 2 маҳал		+	+	+	+	- Ривароксабан 15-20 мг 1 маҳал - Апиксабан 2,5-5 мг 2 маҳал	
2. Бевосита антикоагулянтлар: - Гепарин - Эноксипарин	- Гепарин 5000 ТБ т/о 4 маҳал; - Эноксипарин 100 антиХа ТБ беморни 1 кг вазнига нисбатан 2 маҳал			+	+	+	- Гепарин 5000 ТБ т/о 4 маҳал; - Эноксипарин 100 антиХа ТБ беморни 1 кг вазнига нисбатан 2 маҳал	
3. Антиаритмиклар: - Амиодарон - Верапамил - АТФ - Лидокаин - Эсмолол - Атропин	- Амиодарон 5%-3 мл в/и; - Верапамил 0,25%-2 мл в/и - АТФ 1%-1 мл в/и - Лидокаин 1%-2 мл в/и - Эсмолол 1%-1 мл в/и - Атропин 0,1%-1 мл т/о, в/и		+	+	+	+	- Амиодарон 5%-3 мл в/и; - Верапамил 0,25%-2 мл в/и - АТФ 1%-1 мл в/и - Лидокаин 1%-2 мл в/и - Эсмолол 1%-1 мл в/и - Атропин 0,1%-1 мл т/о, в/и	Терапия муддати клиник ҳолатига боғлиқ
4. Ивабрадин	5-7,5 мг 1 табл. 2 маҳал			+	+	+	10-15 мг	
5. Триметазидин	80 мг 1 марта суткасига, 35 мг 2 марта суткасига			+	+	+	70-80 мг	
6. Ранолазин	500-1000 мг 2 марта суткасига			+	+	+	1000-2000 мг	
7. Ҳалқа диуретиклар: - Фуросемид	- Фуросемид 1%-2 мл в/и;	+	+	+	+	+	- Фуросемид 1%-2 мл в/и;	

- Торасемид	**- Торасемид 2,5%-4 мл в/и**						**- Торасемид 2,5%-4 мл в/и**	
8. Вазопрессорлар: **- Добутамин** **- Допамин** **- Норадреналин**	**- Добутамин 2,5-10 мкг/кг/дақ в/и;** **- Допамин 1-20 мкг/кг/дақ в/и;** **- Норадреналин 0,05-0,3 мкг/кг/дақ в/и**			**+**	**+**	**+**	**- Добутамин 2,5-10 мкг/кг/дақ в/и;** **- Допамин 1-20 мкг/кг/дақ в/и;** **- Норадрена-лин 0,05-0,3 мкг/кг/дақ в/и**	
Изоҳ: [1]Эндокардит билан оғриган беморларда БФ борлигида орал антикоагулянтлари буюрилади.								

(ОПЕРАТИВ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	**РЕЖАЛИ/ШОШИЛИНЧ тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича**				
	Амбулатор ёрдам		**Стационар ёрдам**		
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи	**ОШП/ОП**	**КТМП**	**Туман (шаҳар) шифохоналари**	**Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари**	**Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари**
1. Юрак бўшлиқларини санацияси					
2. Юрак клапанларини реконструкция қилиш					
3. Протезлаш ёки қайта протезлаш (биологик, механик) клапанларни ўрнатиш					
4. Вақтинчали/Доимий ЭКС ўрнатиш					
5. ИКД ўрнатиш				**+**	**+**
6. СРТ ускунасини ўрнатиш				**+**	**+**
7. Радиочастотали аблация				**+**	**+**
8. Аорта ичи баллонли контрпульсацияси				**+**	**+**
Изоҳ: Жарроҳлик аралашувларга бўлган кўрсатмалар кўп тоифали консилиум қарори асосида аниқланиши керак.					

(ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
Парҳез столи ва унинг давомийлиги	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
1. 10-сонли стол умрбод	+	+	+	+	+

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Ҳамшира	+	+	- ўткир асоратланмаган эндокардитдан кейин 1 марта - 3 ой давомида ҳар ойда бир марта ўткир асоратланган эндокардитдан кейин - СЮЕ I-II ФС билан сурункали эндокардит учун: йилига 2 марта; - СЮЕ III-IV ФС билан сурункали эндокардит учун йилига 4 марта	Амбулатор кузатув ўткир эндокардитда 3 ой, сурункали эндокардитда СЮЕ билан бўлса - умрбод
	2. Оилавий шифокор	+			
	3. Кардиолог		+		
	4. Терапевт		+		
	5. Ревматолог		+		
	6. ЛОР		+		
Изоҳ: Юрак-қон томир тизимининг фаолиятини назорат қилиш учун такрорий текширувлар тавсия этилади.					
Лаборатор текширувлар	1. Умумий қон таҳлили	+	+	- ўткир асоратланмаган эндокардитдан кейин 1 марта - 3 ой давомида ҳар	
	2. Умумий сийдик таҳлили	+	+		
	3. СРО	+	+		
	4. Қондаги креатинин	+	+		
	5. АСЛО	+	+		

	6. АЛТ, АСТ, билирубин	+	+	ойда бир марта ўткир асоратланган эндокардитдан кейин - СЮЕ I-II ФС билан сурункали эндокардит учун: йилига 2 марта; - СЮЕ III-IV ФС билан сурункали эндокардит учун йилига 4 марта	
	7. Коагулограмма	+	+		
	8. Тропонин		+		
	9. РФ		+		
Изоҳ: Даврий кўрикларда кўрсатмага мувофиқ қўшимча лаборатор текширувлар тавсия қилинади.					
Инструментал текширувлар	1. ЭКГ	+	+	- ўткир асоратланмаган эндокардитдан кейин 1 марта - 3 ой давомида ҳар ойда бир марта ўткир асоратланган эндокардитдан кейин - СЮЕ I-II ФС билан сурункали эндокардит учун: йилига 2 марта; - СЮЕ III-IV ФС билан сурункали эндокардит учун йилига 4 марта	
	2. ЭХОКГ		+	Кўрсатмага мувофиқ	
	3. ХМЭКГ		+		
	4. Кўкрак қафаси рентгеноскопияси		+		
Изоҳ: Даврий кўрикларда кўрсатмага мувофиқ қўшимча инструментал текширувлар тавсия қилинади.					